

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5085835-56.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: IRACEMA ARAGÃO DE FARIAS

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO E OUTROS

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR - SAÚDE - FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CARBÔMER OU ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL LÍQUIDO OFTÁLMICO PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA - COLÍRIOS NÃO PADRONIZADOS EM LISTA OFICIAL DE DISPENSAÇÃO DO SUS - INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS NO SUS NÃO COMPROVADA - REQUISITOS CUMULATIVOS FIXADOS NO TEMA 106 STJ - INSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, confirmando a decisão do Ev. 3 destes autos, a fim de manter a decisão que, na origem, indeferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de mero incidente processual. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

5085835-56.2024.4.02.5101

510015047927 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5085835-56.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: IRACEMA ARAGÃO DE FARIAS

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora, em face de decisão proferida pelo Juízo da 23ª Vara Federal do Rio de Janeiro nos autos principais nº 5073744-31.2024.4.02.5101 (Ev. 9) que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, solicitada pela autora, para determinar aos réus que forneçam o medicamento Carbômer ou Ácido Poliacrílico Gel Líquido Oftálmico (VIDISIC® GEL) para tratamento de glaucoma (CID X, H 40), conforme prescrição médica.

Em suas razões, sustenta a Recorrente que "O médico assistente ainda aludiu sobre as consequências da não utilização do medicamento que seriam: baixa acuidade visual, ceratite e úlcera de córnea" e que "a manutenção da referida decisão, mormente se considerarmos até o julgamento do presente recurso, evidentemente gerará danos irremediáveis à parte agravante."

Pela decisão do Ev. 3, foi negada a antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões do Estado do Rio de Janeiro.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

A Constituição Federal, em seu art. 196, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, do que decorre, em princípio, uma solidariedade entre os entes federativos, no que diz respeito à sua prestação. Esse regime de responsabilidade solidária instituído pela

Constituição inclui, porque indissociável do dever constitucional de todos os entes federativos de assegurar o direito fundamental à saúde, o fornecimento gratuito de medicamentos às pessoas que não tenham condições financeiras para custear sua aquisição.

Inicialmente, parece-me que, uma vez constatada a necessidade de um tratamento médico para uma pessoa que não tenha condições de custeá-lo, em princípio se impõe ao Estado, em regime de solidariedade entre os entes federativos das três esferas, uma atuação positiva, no sentido de propiciar o tratamento exigido para a preservação de sua saúde, não havendo, neste tocante, margem de discricionariedade para o administrador, senão vinculação que decorre do art. 196 da Constituição Federal.

Embora haja um dever solidário dos entes federados em prover uma assistência integral à saúde, tal qual exposto anteriormente, não se ignora que uma mesma doença possa ser tratada de diversas formas e com diferentes medicamentos, sendo a definição do tratamento adequado a cada caso uma questão de ordem médica e não propriamente de ordem jurídica. Assim, a escolha da alternativa terapêutica adequada a cada doença, quando seu tratamento é feito pelo Sistema Único de Saúde, cabe em princípio ao corpo médico do sistema único de saúde, tal qual estruturado na legislação, devendo tais escolhas ser em princípio prestigiadas pelo Poder Judiciário, na medida em que embasadas em estudos técnicos na área de medicina.

No entanto, embora a escolha do administrador, com base em estudos técnicos, deva ser em princípio prestigiada, não está o Judiciário a ela absolutamente adstrito ou impedido de atuar supletivamente, caso haja nos autos indicativo de que a terapêutica oferecida não tem se mostrado adequada ou suficiente, havendo outras alternativas disponíveis. Entender de modo contrário seria retirar do Poder Judiciário a atribuição de tutelar os direitos fundamentais, em flagrante violação à Constituição.

O exame da questão passa pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, na STA em AgRg 175, onde aquele explicou que o Sistema Único de Saúde filiou-se à corrente da “Medicina com base em evidências”, de modo que **um medicamento ou tratamento em desconformidade com o Protocolo deve ser visto com cautela**, pois tende a contrariar consenso científico vigente. Mais do que isso: a gestão do SUS, obrigado a observar o princípio constitucional do acesso universal e igualitário às ações de saúde, só se torna viável mediante a elaboração de políticas públicas que repartam os recursos (naturalmente escassos) da forma mais eficiente possível. Obrigar a rede pública a financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde existente geraria grave lesão à ordem administrativa e levaria ao comprometimento do SUS, de modo a prejudicar ainda mais o atendimento médico da parcela da população mais necessitada.

Dessa forma, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente.

Com isso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o deferimento pelo Judiciário de medicamento extraordinário fora do âmbito do SUS, deve ficar restrito a hipóteses de rara e especial excepcionalidade:

(a) quando a enfermidade do paciente não for tratada pelo SUS, ou;

(b) quando o tratamento/medicamento disponibilizado pelo SUS não tiver eficácia comprovada no caso concreto.

Caso não se inclua nestas hipóteses, pelo fato de o SUS disponibilizar gratuitamente outros medicamentos para o tratamento da enfermidade, não há que se falar em deferimento pelo Judiciário, sob pena de prejudicar, conforme já explicitado, o acesso universal e isonômico à saúde. E isto porque a opção pelo medicamento listado leva em consideração outros fatores: o custo, a eficácia comprovada e a incidência sobre a patologia tratada, de modo a beneficiar a maior parte da população.

Conclui-se, portanto, que é necessário demonstrar que o tratamento fornecido pelo SUS não é adequado para controle da enfermidade da parte requerente para que, então, possa se fugir ao padrão e deferir terapia diversa, não havendo margem para escolha de tratamento que mais lhe aprouver, desconsiderando as terapias já ofertadas pela Administração Pública, a partir da mera discricionariedade médica, ainda que o profissional esteja vinculado ao SUS.

O Superior Tribunal de Justiça firmou tese, em sede de representativo de controvérsia (tema 106), no sentido de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige-se a presença **cumulativa** dos seguintes requisitos:

(a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

De outro giro, é dizer: o Superior Tribunal de Justiça ratificou os requisitos já fixados pelo Supremo Tribunal Federal, no que tange à prova de **ineficácia do tratamento dispensado pelo SUS, e incluiu 2 novos, quais sejam, a hipossuficiência econômica do requerente e o registro do medicamento** na ANVISA, afastando, assim, o fornecimento de fármacos cuja eficácia não tenha sido atestada por órgãos de controle.

Ao que se colhe da inicial, a parte autora possui diagnóstico de glaucoma, realizando acompanhamento médico junto ao serviço de oftalmologia do Hospital Federal dos Servidores do Estado. "Conforme relata laudo médico, devido a efeitos colaterais de colírios hipotensores, a agravante apresenta olho seco, comprometendo a sua capacidade visual e consequentemente dificultando a execução das suas atividades diárias."

O laudo médico acostado à inicial (Ev. 1.2, fl. 10 dos autos principais), oriundo de instituição pública de saúde, relata que a parte autora necessita do uso do colírio requerido, para o controle de seu quadro. Acrescenta que as opções existentes no SUS foram usadas e não foram eficazes.

A seu turno, de acordo com o Parecer Técnico do Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde (Ev. 7 dos autos principais), infere-se que o fármaco pleiteado está registrado na ANVISA, é indicado para o quadro clínico da parte autora, mas não está padronizado em lista oficial de dispensação do Sistema Único de Saúde.

De toda sorte, em que pese o médico assistente tenha informado insucesso na utilização de alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS, é importante destacar que não há evidência de que a parte autora tenha utilizado sem sucesso ou que haja contraindicação de outro colírio, tendo em vista que não foi especificado quais colírios foram utilizados.

Acresce-se a isso a fundamentação do juízo de origem para a não concessão imediata do colírio, qual seja, que a "finalidade da prescrição é melhorar a qualidade de vida, mas não há situação de urgência ou emergência médica."

Destaco, por fim, que o fato de não haver publicado PCDT específico para Olho Seco não impede a adoção de protocolos para tratamento da condição e a inclusão de fármacos em relações de medicamentos. Nesse ponto, saliento que a solução oftálmica de Hipromelose consta na RENAME¹ ao passo que a solução oftálmica de Dextrano + Hipromelose compõe a REMUME², tratando-se de medicamentos do componente básico.

Repise-se que não há menção à utilização dos referidos medicamentos nos laudos médicos e, portanto, não há prova da ineficácia dos mesmos.

Assim, em juízo de cognição sumária, deve ser mantida a decisão impugnada.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER e NEGAR PROVIMENTO** ao recurso da parte autora, confirmando a decisão do Ev. 3 destes autos, a fim de manter a decisão que, na origem, indeferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de mero incidente processual. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa. É como voto.

1. <https://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2022/01/RENAME-2022.pdf>

2. <https://saude.prefeitura.rio/wp-content/uploads/sites/47/2023/06/Publicacao-Diario-Oficial-de-15.06.2018-Resolucao-3733-de-14.06.2018-remume-2018.pdf>